

- [Home](#)
- [Fiche prepECN](#)
- [Ma Fiche](#)
- [Consensus](#)
- [Imagerie](#)
- [Discussion](#)

Item 185: Arrêt cardio-circulatoire

30 décembre, 2010

Objectifs CNCI

- Diagnostiquer un arrêt cardio-circulatoire
- Prise en charge immédiate (**P**)

Recommandations

- RPC [SFAR-SRLF 06](#)
- Polycopi national: [item 185](#)

Mots-clés / Tiroirs

- FV / TV sans pouls / DEM / asystolie
- Dg < 10s / appel 15 / chercher DSA
- LVAS / MCE +++ / ventilation: 30-2
- CEE: si TV-FV / 150J / 2min de RCP
- SAMU: pose VVP / IOT-MCE-CEE
- Adrenaline 1-5mg / 4min en IVD / tj
- Amiodarone 300mg en IVD / FV-TV
- Remplissage: NaCl IVL / PAM 60
- Surveiller: pouls-scope / capno-SpO2

NPO / PMZ

- Ne jamais interrompre la RCP
- Rechercher/traiter une cause

Â

- Généralités

- Définition
 - ACC = absence d'activité cardiaque et/ou respiratoire spontanée
- Épidémiologie
 - 700 000 ACR/an / survie à 24h < 15% / séquelles neurologiques > 95%
 - !! chaque minute en plus avant la RCP = 10% de survie en moins
- Physiopathologie: 4 arythmies devant un ACR
 - Fibrillation ventriculaire (++)
 - ECG = activité rapide et anarchique à QRS larges polymorphes

- Diminution progressive de l'amplitude des potentiels électriques
- à l'FV → grandes mailles puis FV → petites mailles puis asystolie
- Tachycardie ventriculaire non efficace
 - ECG = TV (QRS larges et réguliers) et absence de pouls
 - Evolution spontanée vers une FV / mesures thérapeutiques
- Dissociation électro-mécanique (« rythme sans pouls »)
 - ECG = persistance d'une activité électrique (QRS) sans aucun battement
 - Elargissement progressif des QRS puis pauses puis asystolie
- Asystolie
 - ECG = aucune activité électrique (ECG isoélectrique ou « plat »)
 - Forme de plus mauvais pronostic / évolution ultimes des autres
- En pratique, CAT du médecin régulateur du SAMU
 - Interrogatoire: bouge pas-respire pas / atcd du patient / heure exacte / adresse précise
 - Instructions: mettre sur le dos sur un plan dur / débiter le MCE (expliquer rapidement)
 - Envoi des secours: déclencher le SMUR le plus proche

À

- Etiologies

- Causes cardiaques: toutes sont possibles
 - SCA ST(+) : infarctus du myocarde (cf [item 132](#))
 - Troubles du rythme (cf [item 325](#))
 - Troubles de la conduction (cf [item 284](#))
 - Tamponnade péricardique
- Causes générales: toute cause d'hypoxie
 - Respiratoires: embolie pulmonaire / PTx compressif / détresse respiratoire
 - Métaboliques: hypo ou hyperkaliémie / acidose métabolique / hypothermie
 - Toxiques: intoxication médicamenteuse (BB, digitaliques, etc: cf [item 214](#))
 - Neurologiques: état de mal épileptique / hémorragie méningée / AVC..

À

- Prise en charge

- Diagnostic précoce (< 10 secondes)
 - Absence de réaction / conscience
 - Absence de respiration spontanée (ou gasps)
 - Absence de pouls carotidien (!! seulement pour les professionnels de santé)
- Prise en charge non spécialisée = RCP de base
 - Alerter et demander de l'aide
 - Appeler ou faire appeler le **15** (réanimateurs si arrêt en hospitalier) (PMZ)
 - Aller faire chercher un défibrillateur automatique externe (DAE)
 - Demander à un autre intervenant de participer à la RCP
 - Avant de débiter: faire noter **l'HEURE** / mise à plat sur un plan dur
 - 1. Libération des voies aériennes
 - Tête en légère hyperextension et subluxation de la mâchoire
 - !! seulement si évidents: retrait de corps étrangers (dentiers)
 - 2. Massage cardiaque externe
 - Bras tendus / talon de la main sur le sternum / FC ~ 100/min
 - A débiter *avant* la ventilation sismique (!! RPC SFAR)

- Rythme: 30 compressions pour 2 insufflations (**30/2**)
- 3. Ventilation
 - Par bouche-à-bouche ou au masque avec ballon
 - 2 insufflations lentes (1s = 500ml) / FR ~ 8/min
 - Rythme: 2 insufflations pour 30 compressions (**30/2**)
- 4. Défibrillation précoce: chocs électriques externes
 - Indication
 - Après **1min30** de RCP devant toute **FV** ou **TV** sans pouls à l'ECG +++
 - !! rythmes « non chocables » : asystolie / dissociation électromécanique
 - Modalités
 - Choc électrique unique de 150J si défibrillateur biphasique (360J si mono)
 - !! immédiatement suivis de **2min** de RCP (5 cycles) **sans** vérifier le scope
 - Si inefficace: augmenter à 360J / !! ne pas interrompre la RCP de base (PMZ)
- Prise en charge spécialisée = RCP médicalisée (SMUR)
 - Mise en condition
 - **Scope** ECG / monitoring cardio-tensionnel
 - **LVAS**: aspiration par sonde gastrique
 - **VVP** en 1^{re} intention (2: voie osseuse / 3: voie endotrachéale / pas de VVC)
 - !! NPO de toujours à noter **l'HEURE** / mettre à plat sur un plan dur
 - Poursuite de la réanimation cardio-pulmonaire
 - Massage cardiaque externe +/- instrumental
 - A poursuivre de façon continue (même après l'intubation +++)
 - Méthodes automatisées: « ventouse » active ou « planche à masser »
 - Ventilation: au masque puis intubation oro-trachéale
 - IOT dès que possible mais seulement si rapide (arrêt de la RCP < 30s !)
 - ventilation mécanique : FR = 10/min / VR = 6mL/kg / FiO2 = 100%
 - Défibrillation: chocs électriques externes
 - Par défibrillateur automatique externe (DAE) / idem que dans la RCP de base
 - Commencer par un choc à 150J puis un second à 360J si échec du 1er
 - **Simultanément**: réanimation médicale
 - Séquence = CEE (+/- CEE) à adrénaline – CEE à amiodarone – CEE à CEE/Ad
 - Abord vasculaire +/- remplissage
 - Cristalloïdes (NaCl 0.9%) 500ml sur 15min pour maintien PAM à 60mmHg
 - Bicarbonates 50mL / seulement si: acidose sévère / hyperK / effet stabilisant
 - Vasopresseur = adrénaline
 - Indications
 - si FV-TV: juste **avant le 2e** ou 3e CEE ou après défibrillation
 - d'emblée si asystolie ou dissociation électromécanique
 - Modalités
 - **1mg** en IVD +/- augmenter à 3mg puis 5mg si asystolie persistante
 - répéter **1x/4min** (tous les 2 cycles de RCP) jusqu'à activité cardiaque
 - Anti-arythmique = amiodarone
 - Indication: en cas de TV-FV / immédiatement **avant le 3e** ou 4e CEE
 - Modalités: **300mg** (2 amp.) IVD puis 150mg puis 900mg/24h si échec
 - !! Remarque: atropine
 - Indication: au cas par cas seulement si DEM (pas si asystolie)
 - Modalités: 1mg IVD +/- augmentation jusqu'à 3mg

- Dans tous les cas: recherche et Tt d'une cause réversible (PMZ)
 - Rechercher
 - Signes d'insuffisance cardiaque / ECG – troponine
 - Signe neurologique focal / boîtes de médicaments
 - CAT en pré-hospitalier
 - SCA = [thrombolyse - aspirine - HNF] / EP = [thrombolyse - HNF]
 - Pneumothorax = exsufflation / tamponnade = drainage
 - Intoxication = antidote / hypothermie = réchauffement, etc.
 - Autres à évoquer: EME / hémorragie méningée / AVC / intoxic CO...
- Surveillance et transfert médicalisé vers réanimation
 - **Pouls** (fémoral-carotidien) / coloration cutanée / pupille / conscience
 - **Scope** ECG / monitoring **PA-SpO2** / **capnométrie** / ventilation
- Au décours (après transfert en réanimation)
 - Bilan et traitement étiologique (PMZ)
 - **Coronarographie**: systématique en l'absence d'étiologie évidente +++
 - Bilan diagnostique: GDS-lactates / troponine / iono-urée-créatinine / TA / RTx..
 - Traitement: d'une hyperkaliémie, d'une tamponnade, d'un pneumothorax, etc.
 - Tt symptomatique et des complications
 - **Hypothermie** thérapeutique: modérée – 24h / améliorer le pronostic neurologique
 - Tt des complications: hémodialyse si défaillance rénale, inotropes si SCA, etc.
 - Lutte contre les ACSOS: équilibre glycémique / maintien PAM ≥ 65 / SpO2, etc.
 - Tt préventif (prévention II)
 - pose d'un DAI: si ACR sur FV **sans** étiologie retrouvée (cf [item 325](#))
- Arrêt de la réanimation
 - Pas de seuil pré-établi: selon le contexte clinique / facteurs pronostiques +++
 - En général arrêt de la RCP si
 - Asystolie persistante malgré ≥ 30 min de réanimation bien conduite
 - *sauf* hypothermie / contexte toxique / cause curable persistante
 - Remarque: une mydriase bilatérale ne signifie pas forcément décès

À

- Evolution

- Facteurs de mauvais pronostic
 - Anamnèse
 - Délai avant le début de la RCP (**no-flow**) > **5min**
 - Durée et qualité de la RCP (**low-flow**) > **20min**
 - Délai avant défibrillation / avant revascularisation coronaire
 - Au décours
 - EEG J1: EEG plat *ou* EME *ou* aspect de burst suppression
 - Clinique J3: GCS ≤ 3 / absence de réflexes du tronc

[A propos](#) - [Conditions Générales de Ventes](#) - [Informations Légales](#) - [F.A.Q](#) - [Nous contacter](#)
 Copyright © 2011 prepECN, all rights reserved - Powered by [Allworldregister.info](http://www.allworldregister.info)

chargement